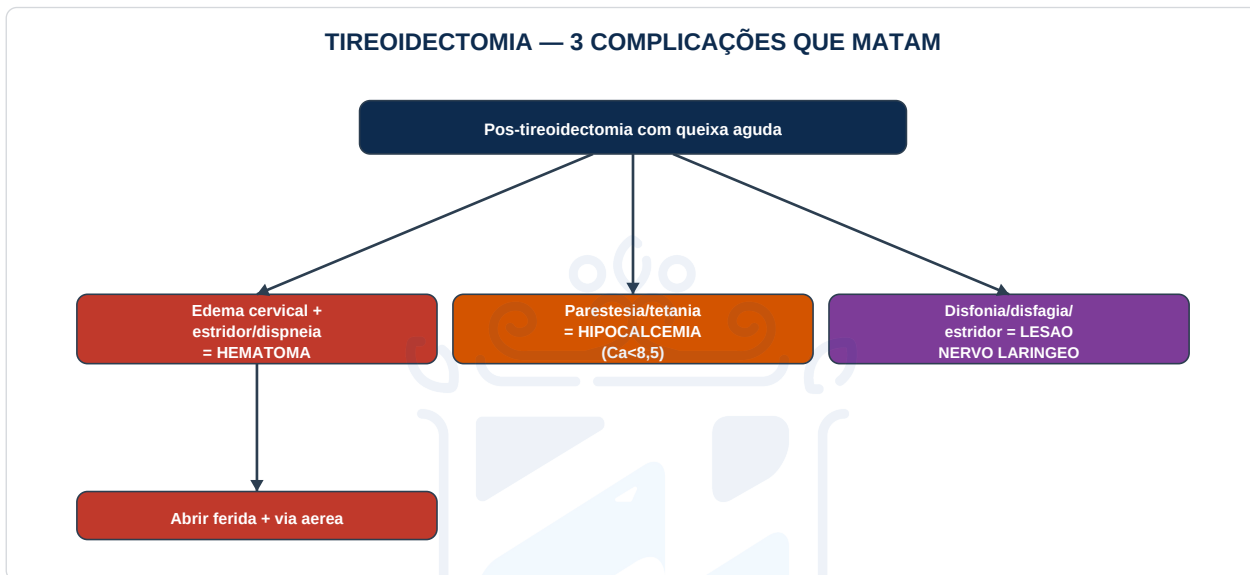


COMPLICAÇÕES AGUDAS PÓS-TIREOIDECTOMIA

FLUXOGRAMA — PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO



1) HEMATOMA CERVICAL — RED FLAG

PERÍODO CRÍTICO: PRIMEIRAS 6 HORAS

- Precoces: piora da dor cervical, assimetria do pescoço, mudança na saída do dreno, tensão cervical
- Tardios (via aérea): disfagia, mudança na voz, ESTRIDOR, dispneia/taquipneia, edema facial/língua, desvio traqueal, agitação
- É emergência: o hematoma comprime a via aérea por obstrução venosa/linfática (edema laríngeo), não só por compressão direta
- CONDUTA: evacuação IMEDIATA dos coágulos à beira-leito se desconforto respiratório importante (abrir a ferida)
- Avaliar necessidade de IOT/traqueostomia; depois levar ao centro cirúrgico para reabordagem (hemostasia)

HEMATOMA — CONDUTA NO PS

Rx

PASSO A PASSO

1. Chamar ajuda (cirurgia/anestesia) e preparar via aérea difícil
2. Se desconforto respiratório importante / edema de mucosa laríngea: ABRIR a ferida e evacuar coágulos à beira-leito
3. Reavaliar via aérea: IOT precoce; se falhar/inviável -> cricotireoidostomia/traqueostomia
4. Quadros sem repercussão grave: encaminhar ao centro cirúrgico para reabordagem
5. Monitorização contínua, O2, acesso e suporte

2) HIPOCALCEMIA — QUANDO SUSPEITAR

POR LESÃO/RESSECÇÃO DAS PARATIREOIDES

- Geralmente TRANSITÓRIA; sintomas iniciam em região perioral e ponta dos dedos
- Parestesia, câimbras, dormência, espasmos e rigidez muscular
- Grave: tetania, laringoespasma, convulsões
- Sinal de Trousseau (espasmo carpopedal ao insuflar o manguito) e Chvostek (contração facial à percussão do facial)
- ECG: prolongamento do QT -> risco de Torsades de Pointes
- Diagnóstico: clínico + Cálcio < 8,5 mg/dL (considerar dosagem 4-6h pós-op para flagrar assintomático)

HIPOCALCEMIA — TRATAMENTO (não esperar laboratório)

Rx LEVE / POUCO SINTOMÁTICO (Ca 7,5-8,5)

Carbonato de cálcio 500mg VO 8/8h (longe das refeições)
Se sem melhora com VO:
Gluconato de cálcio 10% 10mL + SF 50mL EV em BIC, correr em 30 min
Reavaliar sintomas e cálcio seriado

Rx GRAVE / SINTOMÁTICO (Ca < 7,5)

Gluconato de cálcio 10% 20mL + SF 50mL EV em BIC, correr em 20 min
Eleva o cálcio por apenas 2-3h -> MANTER infusão
Manter até regime oral efetivo de cálcio (± calcitriol)
Não aguardar o laboratório para iniciar a reposição
Monitorizar ECG (QT) durante a reposição

3) LESÃO DO NERVO LARÍNGEO RECORRENTE (INFERIOR)

Padrão	Voz / sintomas	Via aérea
Unilateral, paralisia mediana	Pode não ter disfonia; sem disfagia	Preservada
Unilateral, paralisia lateral	Piora da voz, disfagia, broncoaspiração	Geralmente ok
Bilateral, paralisia lateral	Voz ruim, disfagia, broncoaspiração	Respiração 'boa'
Bilateral, paralisia mediana	Dispneia importante	TRAQUEOSTOMIA

LESÃO DO NERVO LARÍNGEO SUPERIOR

RAMOS

- Ramo externo: dificuldade para emitir sons agudos (perda da projeção/voz aguda)
- Ramo interno: engasgos frequentes (perda da sensibilidade supraglótica)
- Lesão bilateral do recorrente em paralisia mediana = dispneia grave -> indicação de traqueostomia
- Documentar a voz e a deglutição; encaminhar à cirurgia de cabeça e pescoço/ORL

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO PÓS-OP

NÃO ESQUECER

- ☐ Inspeção/palpação cervical e do dreno (hematoma) nas primeiras 6h
- ☐ Pesquisar parestesia perioral/dedos e sinais de Chvostek/Trousseau (hipocalcemia)
- ☐ Avaliar voz, deglutição e ruído respiratório (lesão de nervo laríngeo)
- ☐ Cálcio e ECG (QT) se sintomas; iniciar reposição sem aguardar laboratório se sintomático
- ☐ Hematoma com desconforto respiratório = abrir a ferida JÁ

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente em pós-operatório de tireoidectomia (___h) com ___ (hematoma cervical / hipocalcemia / disfonia-estridor).
- Via aérea: ___ (pérvia / IOT / traqueostomia). Cálcio: ___; reposição iniciada: sim/não.
- Hematoma evacuado à beira-leito: sim/não. Conduta atual: ___.
- Solicito reabordagem cirúrgica / vaga / avaliação de cirurgia de cabeça e pescoço.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente 4 horas após tireoidectomia total apresenta abaulamento cervical tenso, disfagia, voz alterada e estridor. Qual a conduta IMEDIATA?

- A) Solicitar TC de pescoço e aguardar resultado
- B) Abrir a ferida cervical à beira-leito para evacuar o hematoma e assegurar a via aérea
- C) Administrar corticoide e observar
- D) Repor cálcio endovenoso
- E) Encaminhar para fonoaudiologia

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente pós-tireoidectomia com parestesia perioral e nas pontas dos dedos, sinal de Chvostek positivo. Qual a conduta?

- A) Aguardar o cálcio sérico antes de qualquer medida
- B) Iniciar reposição de cálcio (VO ou EV conforme gravidade) sem aguardar o laboratório
- C) Administrar bicarbonato
- D) Iniciar antibiótico
- E) Repor potássio

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual lesão nervosa pós-tireoidectomia tipicamente exige traqueostomia por dispneia importante?

- A) Lesão unilateral do nervo laríngeo recorrente em posição mediana
- B) Lesão BILATERAL do nervo laríngeo recorrente em paralisia mediana
- C) Lesão do ramo externo do laríngeo superior
- D) Lesão do ramo interno do laríngeo superior
- E) Lesão isolada do nervo hipoglosso

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre a hipocalcemia pós-tireoidectomia, é correto afirmar:

- A) É sempre permanente
- B) Decorre de lesão/ressecção das paratireoides, é frequentemente transitória e pode prolongar o intervalo QT
- C) Não causa sintomas neuromusculares
- D) Nunca causa arritmia
- E) Dispensa monitorização eletrocardiográfica

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o período mais crítico para o hematoma cervical pós-tireoidectomia?

- A) Após 30 dias
- B) Primeiras 6 horas
- C) Entre o 7o e o 14o dia
- D) Apenas durante a cirurgia
- E) Após 72 horas

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Hematoma cervical expansivo com estridor é emergência de via aérea: abre-se a ferida à beira-leito para descompressão imediata e garante-se a via aérea (IOT precoce; traqueostomia se falhar). Imagem não deve atrasar a descompressão.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Hipocalcemia sintomática pós-tireoidectomia deve ser tratada de imediato (VO se leve, gluconato de cálcio EV se grave), sem aguardar o laboratório. O cálcio confirma ($<8,5$) mas não deve atrasar a reposição.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A lesão BILATERAL do nervo laríngeo recorrente com cordas em posição mediana fecha a via aérea, causando dispneia importante e exigindo traqueostomia. As unilaterais costumam preservar a respiração.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A hipocalcemia decorre de lesão/ressecção das paratireoides, é em geral transitória, cursa com sintomas neuromusculares (Chvostek/Trousseau) e prolonga o QT, predispondo a Torsades — exige monitorização.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

As primeiras 6 horas são o período crítico do hematoma cervical pós-tireoidectomia, quando o risco de expansão e obstrução de via aérea é maior — justificando observação rigorosa nesse intervalo.

SM24
Suporte ao Plantão Médico